

Sangrado uterino anormal (SUA)

1. Introducción y relevancia clínica

El **sangrado uterino anormal (SUA)** se define como **toda alteración en la cantidad, duración o regularidad del sangrado menstrual** que no se explica por embarazo, patología orgánica evidente ni uso de anticonceptivos.

Representa una de las **principales causas de consulta ginecológica en Chile**, especialmente en mujeres en edad fértil y perimenopáusica.

Su diagnóstico correcto requiere una evaluación sistemática que permita **distinguir causas estructurales (PALM)** de **causas funcionales (COEIN)**, según la clasificación internacional de la **FIGO (2011, actualizada 2018)**, adoptada por el **MINSAL**.

□ En EUNACOM, suelen preguntar:

- “¿Cuál es la clasificación PALM–COEIN?”
- “¿Qué examen se solicita en toda mujer con SUA mayor de 40 años?” (respuesta: **biopsia endometrial**).

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Ciclo menstrual normal

El ciclo menstrual depende de la **integridad del eje hipotálamo–hipófisis–ovario–útero**.

El equilibrio entre estrógenos y progesterona regula la **proliferación y descamación endometrial**:

1. **Fase proliferativa:** estrógenos → crecimiento endometrial.
2. **Fase secretora:** progesterona → maduración y estabilización.
3. **Menstruación:** caída hormonal → vasoconstricción → necrosis funcional del endometrio.

Cuando este equilibrio se altera, se produce sangrado irregular, abundante o prolongado.

b. Mecanismos de alteración

- **Anovulación crónica:** estimulación estrogénica sin oposición progestacional → hiperplasia endometrial y hemorragias irregulares.
 - **Trastornos estructurales uterinos:** alteran la contractilidad o integridad endometrial.
 - **Trastornos de coagulación o iatrogénicos:** alteran la hemostasia local.
-

3. Clasificación PALM–COEIN (FIGO 2018)

Grupo estructural (PALM)	Grupo no estructural (COEIN)
P – Pólipo endometrial	C – Coagulopatía
A – Adenomiosis	O – Disfunción ovulatoria (anovulación)
L – Leiomioma (miomas)	E – Endometrial (trastorno primario del endometrio)
M – Malignidad e hiperplasia	I – Iatrogénico (anticoagulantes, ACO, DIU, etc.)
—	N – No clasificado (causa rara)

□ “PALM” = causas **estructurales** (visibles en imagen o histología).
“COEIN” = causas **funcionales o sistémicas**.

4. Tipos clínicos de SUA

Tipo	Característica	Terminología FIGO
------	----------------	-------------------

Menorragia	Sangrado excesivo o prolongado (>7 días o >80 mL)	SUA-H (heavy)
Metrorragia	Sangrado irregular entre menstruaciones	SUA-I (irregular)
Polimenorrea	Intervalo <21 días entre ciclos	SUA-F (frequent)
Oligomenorrea	Intervalo >35 días	SUA-I (infrequent)
Amenorrea	Ausencia de sangrado >6 meses	—

En la práctica, se usa el término **SUA** para todo sangrado uterino anormal no relacionado con embarazo.

5. Diagnóstico clínico

a.

Anamnesis dirigida

- Edad, edad de menarquia/menopausia.
- Frecuencia, duración, volumen del sangrado.
- Métodos anticonceptivos usados.
- Historia de sangrados anormales o hematomas (coagulopatías).
- Fármacos: anticoagulantes, ACO, tamoxifeno.
- Síntomas asociados: dolor pélvico, anemia, dispareunia, infertilidad.

b.

Examen físico

- Evaluar signos de anemia o hipovolemia.
 - Palpación bimanual: tamaño y consistencia uterina (miomas, adenomiosis).
 - Especuloscopia: pólipos cervicales, lesiones visibles.
-

6. Exámenes complementarios

a. Laboratorio básico

- Hemograma → descartar anemia.
 - Prueba de embarazo (β -hCG).
 - TSH → descartar causa endocrina.
 - Pruebas de coagulación → sospecha de coagulopatía (jóvenes con sangrado desde menarquia).
 - Perfil hormonal: FSH, LH, prolactina, estradiol (en casos de anovulación).
-

b. Imagenología

- **Ecografía transvaginal:** examen de primera línea.
 - Evalúa grosor endometrial (>12 mm sugiere hiperplasia en premenopáusicas, >4 mm en posmenopáusicas).
 - Detecta pólipos, miomas, adenomiosis.
 - **Histerosonografía:** útil para diferenciar lesiones intracavitarias.
 - **Histeroscopia:** diagnóstico y tratamiento de pólipos y miomas submucosos.
-

c. Evaluación endometrial

- **Biopsia endometrial:**

- Toda mujer ≥ 40 años o con factores de riesgo (obesidad, anovulación, tamoxifeno, sangrado persistente).
- Objetivo: descartar hiperplasia o cáncer endometrial.

□ En EUNACOM: “Sangrado irregular en mujer de 45 años → biopsia endometrial.”

7. Diagnósticos diferenciales frecuentes

Causa	Edad típica	Características clínicas	Hallazgo diagnóstico
Anovulación crónica (SOP, perimenopausia)	15–25 o >40 años	Ciclos irregulares, sin dolor	FSH/LH alteradas
Pólipo endometrial	30–50 años	Sangrado intermenstrual leve	Ecografía: masa endometrial focal
Miomas submucosos	35–50 años	Menorragia, útero aumentado	Ecografía: nódulo hiperecogénico
Adenomiosis	>35 años, multiparidad	Menorragia + dismenorrea	Utero aumentado, eco heterogénea
Cáncer endometrial	>50 años	Sangrado posmenopáusico	Biopsia positiva
Coagulopatía (Von Willebrand)	Adolescencia	Menorragia desde menarquia	TP/TTPA alterados

8. Tratamiento (según causa y edad)

a.

Manejo médico inicial (sin causa estructural grave)

En atención primaria, el enfoque inicial es médico y conservador.

Grupo	Tratamiento	Mecanismo
Hemodinámicamente estable	ACO combinados (21/7 o continuos)	Suprimen ovulación y estabilizan endometrio
	Progestágenos cíclicos (medroxiprogesterona, norethisterona)	Antiestrogénico, estabiliza endometrio
	AINes (ibuprofeno, naproxeno)	Disminuyen prostaglandinas y volumen
	Ácido tranexámico (1 g cada 8 h por 3–5 días)	Antifibrinolítico
Sangrado agudo abundante	Anticonceptivos combinados en altas dosis o medroxiprogesterona oral	Detiene hemorragia activa

☐ En Chile, el MINSAL recomienda:

- **ACO combinados** o **progestágenos** como primera línea en mujeres <40 años sin patología orgánica.
- **DIU con levonorgestrel** como opción de control crónico.

b.

Manejo quirúrgico

Causa	Tratamiento quirúrgico
Pólipos endometriales	Histeroscopia y polipectomía
Miomas submucosos	Miomectomía o resección histeroscópica
Adenomiosis difusa	Histerectomía si no desea fertilidad
Hiperplasia atípica / cáncer endometrial	Histerectomía + evaluación oncológica
Las opciones quirúrgicas se reservan para sangrados refractarios o lesiones estructurales confirmadas .	

9. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Mecanismo	Consecuencia
Anemia ferropénica	Pérdida crónica de sangre	Fatiga, disnea, taquicardia
Hiperplasia endometrial	Estimulación estrogénica sin oposición	Riesgo de cáncer endometrial
Infertilidad	Alteración del ciclo ovulatorio	Anovulación crónica
Compromiso hemodinámico	Hemorragia aguda	Hipotensión, shock hipovolémico

El pronóstico es excelente con diagnóstico etiológico oportuno y manejo integral.

10. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. El SUA se clasifica según **PALM–COEIN** (FIGO 2018).
2. En mujeres >40 años o con riesgo de cáncer → **biopsia endometrial**.
3. **Ecografía transvaginal** es el examen inicial de elección.
4. **AINEs y progestágenos** son primera línea en hemorragia leve/moderada.
5. **Ácido tranexámico** se usa en sangrados agudos.
6. **Miomas y pólipos** son las causas estructurales más comunes.
7. **Ciclos anovulatorios crónicos** (SOP, perimenopausia) → causa funcional frecuente.



Errores comunes

- No descartar embarazo antes de estudiar el sangrado.
- Tratar sin realizar ecografía ni biopsia en mujeres mayores de 40 años.
- Indicar ACO sin evaluar contraindicaciones.
- Subestimar anemia o sangrado severo.
- No derivar oportunamente ante sangrado postmenopáusico.

11. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **SUA** es una alteración del patrón menstrual por causas estructurales o funcionales.

2. Clasificación **PALM–COEIN**: Pólipo, Adenomiosis, Leiomioma, Malignidad / Coagulopatía, Ovulatoria, Endometrial, Iatrogénica, No clasificada.
3. **Ecografía transvaginal** es el estudio inicial; **biopsia endometrial** si >40 años o sangrado persistente.
4. Tratamiento inicial: **AINEs, progestágenos, ACO o ácido tranexámico**.
5. **DIU con levonorgestrel** es eficaz para control crónico del sangrado.
6. En sangrado agudo: **manejo hemodinámico + anticonceptivos en altas dosis**.
7. Siempre descartar embarazo antes de estudiar o tratar.